以老年人为例分析专业权威与熟人信任的博弈：医疗决策中的“信邻非医”现象研究

Powder[1]

双城家庭伦理重点研究室，双城大学祖安研究院伦理学系，双城祖安，123456；

摘要

在老龄化进程加速的背景下，老年人医疗依从性低是一个突出的公共卫生问题。其中，老年人倾向于采信周边邻居的非专业建议而忽视医生专业医嘱的“信邻非医”现象尤为典型。本文基于社会学视角，运用“差序格局”理论，探讨了这一现象背后的深层逻辑。研究发现，“信邻非医”并非单纯的健康素养缺失，而是专业权威与熟人信任在特定场域下博弈的结果。在博弈过程中，基于情感共鸣和地缘共同体的熟人信任，往往因符合老年人的心理需求、语言习惯及低成本信息获取特征，压倒了基于制度和技术但缺乏温度的专业权威。这种信任错位不仅导致了严重的健康风险，也折射出当前医患关系的结构性困境。文章建议，改善这一现象需重构医疗信任机制，通过将专业医疗服务嵌入社区熟人网络，实现从“技术施治”向“人文关怀”的转变。

关键词：专业权威；熟人信任；医疗决策；治疗依从性；社会网络

1 引言

1.1 研究背景与问题提出

随着人口老龄化程度的加深，老年慢性病管理已成为社会治理的重要组成部分。然而，在临床实践与社区观察中，一种悖论现象屡见不鲜：老年人往往对医生基于科学证据的专业医嘱持怀疑或敷衍态度，却对邻居基于个人经验的“偏方”、“现身说法”深信不疑。这种“信邻非医”现象，不仅导致了医疗资源的浪费，更严重威胁着老年人的身心健康。本文将这一决策偏好概括为“信邻非医”现象。

“信邻非医”并非一个非此即彼的二元选择，而是老年决策者在具体生活情境中，

对两种性质迥异的信任资源进行权衡、拼贴与调用的复杂过程。这背后是一场基于所获信息的“博弈”。博弈的一方是专业权威，其合法性根植于系统的科学知识体系、制度化的职业资质认证以及基于循证医学的普适性治疗规则。它代表了一种“系统信任”或“制度信任”，具有抽象性、普遍性与去人格化特征。博弈的另一方是熟人信任，它生成于以地缘、亲缘和情感纽带为基础的强关系网络，通过高频次、面对面的日常互动得以维系和强化。其效力来源于具体情境中的经验共享、情感共鸣与道德义务，是一种典型的“人际信任”或“特殊信任”。

现有研究多从健康素养低下、认知功能衰退等个体层面解释老年人的非理性行为，却相对忽视了其背后的社会关系网络与信任结构的影响。为何拥有专业知识的医生在决策博弈中常常败给非专业的邻居？熟人社会的信任逻辑是如何消解现代医学的权威地位的？本文试图从“专业权威”与“熟人信任”博弈的视角，对这一问题进行深入剖析。

1.2 研究意义

从社会学角度审视“信邻非医”现象，有助于跳出单纯的“健康素养低下”的个体归因范式，揭示老年群体在医疗决策中的社会关系网络运作逻辑。这对于优化医患关系、构建老年友好型医疗环境、提升基层卫生治理能力具有重要的理论与现实意义。

2 文献综述与理论框架

2.1 文献综述

既有的关于老年人医疗决策的研究多集中于医学心理学与公共卫生领域，侧重于分析认知能力、健康素养对依从性的影响。社会学视角的研究虽已关注到社会支持网络的作用，但多强调其正向功能，相对忽视了熟人网络作为“非正式信息源”对专业权威的负向干扰与消解作用。

2.2 理论框架

本研究主要援引以下社会学理论工具：

差序格局理论： 用于分析中国社会人际关系亲疏远近的波纹结构，解释为何老年人

倾向于信任处于“内圈”的邻居而非“外圈”的医生。

信任理论： 区分“人格信任”与“系统信任”，探讨两种信任模式在医疗场域的冲突。

社会资本理论： 将邻里关系视为一种社会资本，分析其在信息交换与行为约束中的力量。

2.3 分析视角

既有研究为理解“信邻非医”提供了多重视角，但存在整合不足的局限。

1. 患者视角研究：多从“健康素养”出发，将不遵医嘱归因于患者知识、技能与动机的不足。这虽具解释力，但易将复杂的社会文化过程简化为个体认知缺陷，忽略了社会网络的支持与掣肘双重作用。
2. 医患关系视角研究：聚焦于医患沟通质量、时间压力与信任建立。研究表明，程式化、权威式的沟通会削弱治疗同盟。然而，此视角常将“医”与“患”预设为封闭的二元互动，未能充分纳入“熟人网络”这一强大的第三方力量如何渗透并重塑这一关系。
3. 社会网络与健康传播研究：强调了非正式社会支持对健康行为的显著影响，以及健康谣言在强关系中的传播效力。这类研究明确了熟人网络的重要性，但较少深入剖析其与专业系统在同一个体决策心智中是如何具体交锋、协商的。

为整合上述视角，本文认为，老年患者的医疗决策是在特定的场域如医疗机构的正式空间、社区公园的闲聊场景、家庭内部中做出的。在不同的场域，主导的“资本”类型不同。患者的决策习惯则受到其认知模式与情感需求的深层驱动。专业权威与熟人信任，作为两种不同的“资本”和“话语”，在该场域中争夺对患者习惯的影响力，博弈的结果即外显为“信邻非医”及其程度各异的行为谱系。

3 研究方法与对象

3.1 研究方法

本研究采用定性研究方法。 通过半结构化访谈收集资料，运用扎根理论编码技术进

行数据分析，提炼核心范畴。

3.2 研究对象

选取某省会城市两个老旧社区，对 30 名患有至少一种慢性病的 60 岁以上老年人进行深度访谈，同时访谈社区全科医生 5 名。

4 研究结果

4.1 信邻非医”的现象表征与生成逻辑

研究发现，“信邻非医”主要表现为三种形式：

1. 经验替代科学： 以邻居的“现身说法”替代医生的循证医学建议。
2. 信息的过滤与重构： 选择性接受符合自身心理预期的邻里建议，将医生的严厉医嘱解读为“危言耸听”或“商业牟利”。
3. 群体性模仿： 社区内形成特定的“用药共识”或“养生风气”，与正规治疗方案相悖。

熟人信任在博弈中常占据上风，主要通过以下机制实现：

1. 认知亲和机制：熟人信任所获得的信息天然实现了生活世界对科学世界的“转译”。哈贝马斯指出，生活世界与系统存在张力。专业医学知识具有高度的抽象性、专业术语化等特点，这对于习惯具象思维的老年人构成认知门槛。相反，熟人提供的是一种“叙事性知识”：“我隔壁老张，也是你这个病，吃了某某偏方，现在上五楼不喘气。”这种知识根植于“生活世界”，以具体人物、生动故事和可感知的结果呈现，更易被理解、记忆和模仿。老年人通过熟人网络，实际上完成了一次对陌生、威严的医学知识的“转译”和“驯化”，使其变得熟悉、可控。
2. 情感优先机制：强关系纽带中的“安全感”生产。医患关系本质上是基于契约的、短暂的、目标导向的弱关系。尽管医生秉持专业精神，但门诊的“时间暴政”常使互动显得匆忙、缺乏温情。熟人网络则提供了一种持续性的、充满人情味的“关怀政治”。邻居的叮嘱往往包裹着“为你着想”的情感外衣，这种情感支持本身就能产生心理安慰剂效应，满足老年人对“被关心”的深层需求。在

“冷冰冰的科学道理”与“热乎乎的人情关怀”之间，情感逻辑时常压过工具理性。同时，在中国乡土社会的逻辑中，信任强度与关系亲疏成正比。邻居虽无血缘，但因长期的地缘共居、互助互动，已演变为“拟亲属”关系，处于信任圈层的内环。相比之下，医生作为陌生人，虽有制度背书，但处于信任圈层的外环。当二者信息冲突时，老年人本能地依据“自己人/外人”的二元划分，选择信任邻居。

3. 自主赋能机制：在熟人网络中重获“掌控感”。面对复杂的疾病和专业的医疗体系，老年人易产生无力感和被动性。听从单一权威的指令，可能强化这种“患者”角色。而在熟人网络中，老年人可以主动询问、多方打听、比较甄别，最终做出一个“自己的选择”。这个过程本身赋予其决策的自主感和对自身生活的掌控感，这种心理收益有时甚至超过了对治疗方案客观效用的考量。
4. 场域共振机制：结构性力量的强化。上述心理机制被更大的结构性场域所放大。一方面，基层医疗中“三分钟门诊”成为常态，医患沟通的“制度性疏离”难以弥补。另一方面，熟人社区构成了一个“回音壁”，相似的观点和经验被不断重复和强化，形成“群体极化”，进一步确证了非专业建议的“正确性”。此外，海量的、经过人情化包装的伪科学健康信息在网络与线下熟人圈中流布，为“信邻”提供了看似无穷的“弹药”。

5 后果分析

5.1 健康风险的个体化承担

熟人信任虽然降低了信息获取的心理门槛，却无法保证信息的科学性。盲从邻里经验往往导致病情延误、药物不良反应增加，引发可避免的并发症，甚至造成急性事件及药物性肝肾功能损伤。根据目前报告的医疗决策可发现，这一现象已蔓延至罕见病患者，最终由老年人个体承担后果，加剧了健康不平等。

5.2 医患关系的结构性断裂

“信邻非医”现象实质上是专业权威在基层社会的合法性危机。当邻居成为“非正式意见领袖”，医生的专业话语权被架空，医患沟通成本剧增，治疗方案的连续性被打断，甚

至引发医患纠纷，导致信任崩溃，形成“沟通不畅-依从性差-疗效不佳-信任更低”的恶性循环。

5.3 社区健康生态的异化

错误的健康信息在熟人网络中通过“回音室效应”不断强化，形成社区内的反科学亚文化，增加了公共卫生干预的难度。在家庭内部，持科学观念的子女与坚信邻居经验的父母之间，常因此产生激烈争执，影响家庭和谐与照护质量。

6 小结

本研究将“信邻非医”重构为一场专业权威与熟人信任在老年患者决策场域中的复杂博弈。研究发现，熟人信任并非对专业权威的简单“背离”，而是在认知亲和、情感满足与自主赋能上，为老年人提供了专业医疗体系未能充分供给的“补偿性价值”。因此，解决之道不在于贬低或切断老年人的熟人网络，而在于如何引导博弈从零和走向正和，实现两种信任资源的协同与整合。

这需要系统性的干预：

1. 赋能个体，升级“健康素养”：健康教育应从知识灌输转向“批判性健康素养”培养，教会老年人如何评估信息源、辨别谣言，理解医学的“不确定性”与个体差异，提升对医学专业人士的信赖。
2. 导流网络，转化“社会资本”：识别并培育社区中的“健康意见领袖”，如患教良好的退休医生、教师，将熟人网络从非正式信息的“策源地”转化为传播科学知识、提供心理支持的“健康促进社区”。鼓励社区组织举办由专业医生主导的、开放式的健康讨论会。
3. 政策协同，构建“整合照护”网络：强化家庭医生签约服务的“守门人”与“经纪人”角色，使其成为连接专业医疗与社区家庭的稳固桥梁。推动形成“医疗机构-社区组织-家庭”三位一体的支持闭环，让专业指导能够以更人性化、更可持续的方式融入老年人的日常生活场景。

“信邻非医”现象是老年人在特定的社会关系网络与信任结构下做出的理性选择，尽

管其结果往往是非理性的。在这场专业权威与熟人信任的博弈中，获胜的往往是承载着情感与关系资本的后者。要改变这一现状，必须重塑医疗服务的供给模式，让专业医疗力量有效嵌入老年人的熟人社会网络，构建一种融合了专业性与人情味的新型信任契约。

作者信息

作者

Powder：双城家庭伦理重点研究室，双城大学祖安研究院伦理学系，双城祖安，123456；

致谢

本工作得到锅夹自燃科学鸡精（2026-8-428890648）和符文大陆基本科研业务费（ZAUN 202603001）的资助。感谢希维尔先生，赛维卡大姐和范德尔叔叔对本工作的大力支持。

参考文献

[1] 费孝通. 乡土中国[M]. 天津：天津人民出版社，1948.

[2] Anthony Giddens. The Consequences of Modernity[M]. University of Chicago Press, 1991.

[3] 杨菊华. 健康老龄化："医""养"结合的中国道路[J]. 社会科学战线，2017(12): 15-25.

[4] 胡琳琳， 刘晓云. 医患信任的影响因素及其构建机制研究述评[J]. 中国医院管理， 2020, 40(08): 1-4.

[5] Giddens, A. *The Consequences of Modernity*. Stanford University Press, 1990.

[6] Freidson, E. *Professionalism: The Third Logic*. University of Chicago Press, 2001.

[7] Hobbs, R., et al. The Role of Non-Professional Sources in the Health Information Ecology of Older Adults. *Journal of Health Communication*, 2022, 27(3): 168-177.

[8] Lupton, D. The "Mediatization" of Health Care: Health Policy, Health Care Delivery and Health Education in the Digital Age. *Social Theory & Health*, 2014, 12(4): 409-424.

[9] Qiao J B, Pei J Y, Zhang Y, et al. Divergent Total Synthesis of Pleurotinoid Natural Products[J]. Journal of the American Chemical Society, 2025, 147(44): 40093-40098.